FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB)
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (HUB)





APLICAÇÃO: 2019

MANHÃ

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1 **Ao receber este caderno de prova, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua Folha de Respostas. Confira também o seu nome em cada página numerada deste caderno de prova (desconsidere estas instruções, caso se trate de caderno de prova reserva)**. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua **Folha de Respostas**, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e(ou) apresente divergência quanto aos seus dados pessoais, solicite, de imediato, ao(à) aplicador(a) de prova mais próximo(a) que tome as providências necessárias.

2 Durante a realização da prova, não se comunique com outros(as) candidatos(as) nem se levante sem autorização de um(a) dos(as) aplicadores(as) de prova.

3 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da **Folha de Respostas**.

4 Ao terminar a prova, chame o(a) aplicador(a) de prova mais próximo(a), devolva-lhe a sua **Folha de Respostas** e deixe o local de prova.

5 Nenhuma folha deste caderno pode ser destacada, exceto a **Folha de Respostas**, cujo cabeçalho será destacado pelo(a) chefe de sala ao final da prova, para fins de desidentificação.

6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na **Folha de Respostas** implicará a anulação da sua prova.

OBSERVAÇÕES:

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

UnB | HUB

Cebraspe
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 0(XX) 61 3448-0100 | www.cebraspe.org.br | sac@cebraspe.org.br

VOCÊ SABIA?

O **Cebraspe** é o detentor exclusivo do **Método Cespe** de realização de avaliações, certificações e seleções. Esse método está em constante evolução, sendo desenvolvido e aperfeiçoado a partir de pesquisas acadêmicas, algoritmos, processos estatísticos e outras técnicas sofisticadas. Tudo isso para entregar resultados confiáveis, obtidos com inovação e alta qualidade técnica.

- Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.
- Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "Espaço livre" — que constarem deste caderno de prova poderão ser utilizados para rascunho.

PROVA OBJETIVA

Paciente de sessenta anos de idade, etilista crônico e diabético, deu entrada no pronto-socorro de um hospital com quadro de cefaleia intensa, febre e vômitos em jato, sintomas iniciados havia um dia. No exame físico, o paciente apresentou inquietação e confusão mental, rigidez de nuca e nistagmo. O exame de líquor evidenciou os seguintes resultados: aspecto turvo; leucócitos = 1.540 mm^3, sendo 1.460 neutrófilos; proteínas = 120 mg/mL; e glicose = 29 mg%.

Com relação ao caso clínico apresentado e a aspectos diversos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

1 O quadro clínico em questão é compatível com o diagnóstico de meningite bacteriana, e o agente etiológico mais provável é o *Streptococcus pneumoniae.* Nesse caso, a antibioticoterapia empírica deve ser iniciada com penicilina cristalina intravenosa, na dose de 3.000.000 UI de 4 h em 4 h.

2 A próxima conduta a ser tomada é determinar que o referido paciente realize uma tomografia computadorizada de crânio, a fim de investigar o quadro de nistagmo e confusão mental.

3 Caso sejam encontrados diplococos Gram-negativos na bacterioscopia do líquor, indica-se antibioticoterapia inicial com ampicilina intravenosa.

4 Os contactantes domiciliares desse paciente devem receber quimioprofilaxia com isoniazida durante 2 dias, a ser iniciada preferencialmente até 24 h após o diagnóstico do caso primário.

Paciente de quinze anos de idade foi admitido em unidade de pronto atendimento apresentando, havia uma semana, quadro de artrite, que inicialmente acometera o joelho e o tornozelo direitos, mas, após 3 dias, havia migrado para o cotovelo direito e o tornozelo esquerdo. Ao exame físico, foi detectado um sopro holossistólico em foco mitral, irradiado para a região axilar esquerda. O paciente relatou ter tido um episódio de amigdalite cerca de 3 meses antes desse quadro, tendo sido tratado, à época, com anti-inflamatórios.

Com relação ao caso clínico descrito e a aspectos diversos a ele relacionados, julgue os itens seguintes.

5 O diagnóstico desse paciente é de febre reumática, e o tratamento inicial consiste na administração de anti-inflamatórios não esteroidais e corticoide em dose alta durante o período de 6 semanas a 12 semanas, não sendo indicado o uso de antibióticos.

6 Se houver regressão da cardite, o paciente em questão deverá receber penicilina benzatina na dose de 1.200.000 UI intramuscular a cada 21 dias, até ele completar vinte e cinco anos de idade.

7 Se a dosagem de anticorpos antiestreptolisina (ASLO) no paciente for negativa, as hipóteses diagnósticas mais prováveis passarão a ser lúpus eritematoso sistêmico ou artrite reumatoide juvenil.

8 Caso o referido paciente não utilize anti-inflamatórios não esteroidais, o quadro clínico poderá evoluir para lesões articulares permanentes e limitantes.

Em relação à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), julgue os itens que se seguem.

9 **Situação hipotética**: Um paciente de vinte e cinco anos de idade compareceu ao atendimento médico com quadro de pirose retroesternal iniciada havia 2 meses, com frequência de 3 vezes por semana, regurgitação frequente e anemia ferropriva leve. **Assertiva**: Nesse caso, é dispensável a realização de endoscopia digestiva alta para o diagnóstico de DRGE, sendo recomendado iniciar o tratamento com inibidor de bomba de prótons por 4 semanas.

10 É imprescindível a realização de uma pHmetria de 24 h antes de se instituir tratamento a pacientes com suspeita de refluxo gastroesofágico, sintomáticos, que não apresentem erosões esofágicas na endoscopia digestiva alta.

11 A impedâncio-pHmetria é um exame que pode ser utilizado para detectar refluxos não ácidos em pacientes com sintomas persistentes.

12 Asma, tosse crônica, dor torácica retroesternal não cardíaca, halitose e pneumonias de repetição podem ser causadas por refluxo gastroesofágico.

13 O esôfago de Barrett é uma complicação da DRGE caracterizada por metaplasia colunar do epitélio esofágico, que é eficazmente tratado por meio de ablação endoscópica.

A respeito do diagnóstico e do tratamento de doenças pulmonares, julgue os itens a seguir.

14 Se um paciente apresentar hemitórax direito com expansibilidade preservada, frêmito toracovocal aumentado, submacicez à percussão e murmúrio vesicular reduzido, com presença de estertores crepitantes, o diagnóstico provável será síndrome de condensação, compatível com o diagnóstico de pneumonia bacteriana ou tuberculose.

15 Pectoriloquia afônica no campo médio do hemitórax esquerdo é um achado compatível com derrame pleural.

16 Ritmo respiratório de Kussmaul, observado nos casos em que há processos expansivos e acometimento do encéfalo, indica lesão no centro respiratório.

17 **Situação hipotética**: Uma paciente de trinta e oito anos de idade foi atendida em um hospital. O exame físico revelou que a paciente utilizava músculos acessórios da respiração. Além disso, o exame evidenciou hipersonoridade à percussão e murmúrio vesicular diminuído com expiração prolongada e sibilos em todo o tórax. **Assertiva**: Nesse caso, é recomendado o tratamento inicial com 3 ciclos de inalações com beta-2 agonistas de curta duração, associados ou não a anticolinérgico de curta duração.

Homem de sessenta anos de idade, hipertenso em uso crônico de metildopa, diabético em uso de insulina, obeso, não etilista, realizou exames laboratoriais de rotina, que evidenciaram aspartato aminotransferase (AST) = 89 e alanina aminotransferase (ALT) = 120. O médico que o avaliou solicitou novos exames.

A respeito do caso clínico apresentado, julgue os itens subsecutivos.

18 Após a realização de novos exames, como a sorologia para hepatite B, os resultados mostraram HBsAg negativo, anti-HBc negativo e anti-HBs positivo, justificando as alterações de transaminases.

19 O referido paciente foi submetido à sorologia para hepatite C, que revelou anti-HCV positivo. Com base nesse resultado, conclui-se que o diagnóstico é de hepatite C.

20 O uso de metildopa pode estar associado ao aumento de transaminases.

21 Uma hipótese diagnóstica provável é esteato-hepatite não alcoólica, que pode estar associada à síndrome metabólica apresentada pelo paciente, mas que só poderá ser confirmada após exclusão de outras doenças hepáticas.

Mulher de quarenta e três anos de idade estava realizando acompanhamento clínico para investigação de poliartrite com rigidez matinal que acometia, havia 2 meses, os dois punhos e quatro articulações metacarpofalangianas da mão direita.

Com relação a esse caso clínico, julgue os itens a seguir.

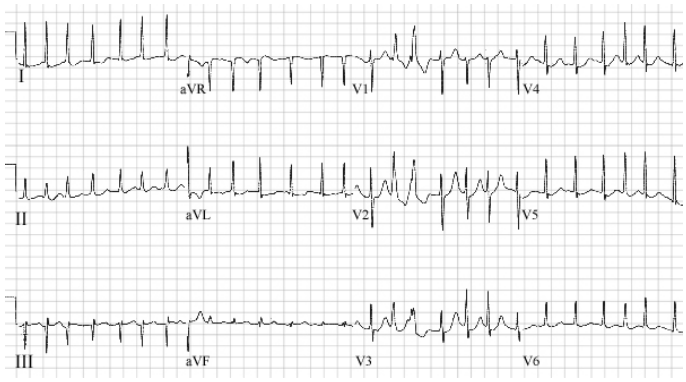
22 Se a pesquisa de fator reumatoide nessa paciente for positiva, o diagnóstico será artrite reumatoide.

23 Devem ser considerados os seguintes diagnósticos diferenciais para o quadro clínico descrito: lúpus eritematoso sistêmico, artrite psoriásica, osteoartrite e fibromialgia.

24 No caso em apreço, deve ser realizada a radiografia de mãos e punhos, que pode detectar diminuição do espaço articular, edema de partes moles, erosões ósseas marginais e osteopenia periepifisária.

25 O quadro clínico apresentado pela paciente é altamente sugestivo de osteoartrite, que acomete preferencialmente as articulações metacarpofalangianas.

Um paciente de sessenta e oito anos de idade, com diagnóstico de diabetes melito do tipo 2 havia oito anos, em uso regular de metformina 2 gramas ao dia, compareceu a ambulatório com queixa de dispneia. Segundo o paciente, havia três meses que se iniciara um quadro de dispneia aos esforços maiores que os habituais e, nas últimas duas semanas anteriores à consulta, o quadro tinha evoluído para dispneia aos médios e pequenos esforços. No exame físico, o paciente estava normocorado e com extremidades quentes, apresentando frequência cardíaca de 118 bpm, pressão arterial de 128 mmHg × 74 mmHg, turgência jugular a 30° e ausculta pulmonar normal. O *ictus cordis* era propulsivo no 6.º EICE – linha axilar anterior, o ritmo cardíaco era irregular em galope (presença de terceira bulha) e sem sopros. Adicionalmente, notou-se refluxo hepatojugular e edema de membros inferiores na região maleolar bilateralmente. Os exames laboratoriais do paciente apresentaram os seguintes resultados: hemoglobina = 9,5 g/dL; hematócrito = 29%; volume corpuscular médio = 86 fL; creatinina = 1,8 mg/dL; sódio = 130 mmol/L; hemoglobina glicada = 7,3 g/dL; e glicemia de jejum = 161 mg/dL. Os demais exames laboratoriais não revelaram anormalidades significativas. O eletrocardiograma com a calibração padrão mostrou o seguinte resultado.



Com relação ao caso clínico apresentado, julgue os itens a seguir.

26 De acordo com as informações do quadro clínico desse paciente, espera-se que o valor do NT-pro BNP seja inferior a 300 pg/mL.

27 Há preditores prognósticos adversos entre os resultados dos exames laboratoriais desse paciente.

28 Esse paciente deve iniciar o uso de ácido acetilsalicílico, para adequada prevenção de eventos tromboembólicos.

29 É contraindicado o uso de enalapril por esse paciente, devido ao risco de piora da função renal.

30 É recomendável o uso do carvedilol por esse paciente, visando-se ao remodelamento reverso ventricular esquerdo e à redução da morbimortalidade.

31 Para elucidar a etiologia da condição clínica apresentada por esse paciente, é indicada a avaliação não invasiva de isquemia miocárdica.

32 Deve ser proposta a esse paciente dieta hipossódica com ingesta de até cinco gramas de sal por dia.

Considerando as orientações do Ministério da Saúde acerca da dengue, chikungunya e zika, julgue os próximos itens.

33 Em razão da semelhança entre alguns sinais e sintomas da dengue, da zika e da chikungunya, recomenda-se que, nos casos de suspeita inicial de zika, a testagem seja iniciada por métodos diretos, em amostras coletadas até o 5.º dia de início dos sintomas.

34 Artralgia intensa associada a edema articular é mais frequente na chikungunya que na dengue.

35 Conjuntivite e linfonodomegalia são mais frequentes na zika que na dengue.

36 Recomenda-se o uso de anti-inflamatórios não esteroides na fase aguda das arboviroses que cursam com artralgia e edema intensos, para preservação das articulações.

Uma mulher de cinquenta e seis anos de idade, portadora de diabetes melito do tipo 2 havia 18 anos e de doença vascular periférica com amputação do quarto e quinto pododáctilos esquerdos, retornou a ambulatório seis meses após ter recebido orientações sobre mudanças no estilo de vida (dieta, perda de peso e atividade física), fornecidas em razão de elevação das enzimas hepáticas associada a alterações visualizadas na última ultrassonografia abdominal. A paciente fazia uso de aspirina, amlodipina e insulina regularmente, mas negou o uso de tabaco ou de álcool. No exame físico, ela apresentava peso = 85 kg; altura = 1,62 m; circunferência abdominal = 96 cm; pressão arterial = 132 mmHg × 82 mmHg (média de três medidas, com a paciente sentada); e frequência cardíaca = 62 bpm. Foi observado edema sacral sem estigmas de doença hepática crônica e com os demais sistemas normais. Os resultados dos exames laboratoriais revelaram: ferritina = 440 µg/L; AST = 95 UI/L; ALT = 70 UI/L; GGT = 40 UI/L; colesterol total = 234 mg/dL; HDL-C = 34 mg/dL; LDL-C = 150 mg/dL; triglicérides = 250 mg/dL; glicemia de jejum = 142 mg/dL; e hemoglobina glicada (A1C) = 7,6%. As sorologias para hepatite A, B e C resultaram negativas; o TAP e os demais exames de rotina, normais. Exame de ultrassonografia revelou o parênquima hepático com ecogenicidade aumentada em relação ao córtex renal, com ascite leve e sem outras anormalidades (inalterado em relação à ultrassonografia realizada havia seis meses).

A respeito desse caso clínico, julgue os itens subsequentes.

37 Recomenda-se a biópsia hepática para confirmar o diagnóstico e estabelecer o prognóstico para essa paciente.

38 A resistência à insulina é o mecanismo mais provável da condição clínica apresentada por essa paciente.

39 O uso de metformina é indicado para regressão da lesão hepática e prevenção da fibrose.

40 As estatinas são contraindicadas a essa paciente, por aumentarem o risco de lesão hepática induzida.

41 Deve-se indicar a realização de tomografia de tórax a essa paciente, porque a obtenção do seu escore de cálcio coronário é necessária para a adequada estratificação do seu risco cardiovascular.

42 É recomendável o uso de vitamina E por essa paciente.

Julgue os seguintes itens, a respeito do sarampo.

43 O sarampo é provocado por um vírus DNA da família *Poxviridae*.

44 O sarampo caracteriza-se por pródromo brando que inclui febre, dor de cabeça e sintomas respiratórios superiores. Posteriormente, a doença evolui com erupção de máculas e pápulas eritematosas faciais, máculas petequiais eritematosas no palato, linfadenopatia cervical e artralgia.

45 Para pessoa exposta ao sarampo, recomenda-se a rotineira imunização passiva com o uso de imunoglobulina.

Um paciente de vinte e seis anos de idade sem antecedentes patológicos compareceu a ambulatório com queixa de síncope. Ele tivera, havia três dias, um episódio súbito de síncope sem pródromos, sem liberação esfincteriana ou período pós-ictal enquanto jogava bola, em um dia muito quente, tendo recuperado a consciência em torno de cinco minutos após o episódio. O paciente negou fatores de risco para doença arterial coronária e relatou que, embora seus pais e seu irmão, de dezoito anos de idade, fossem aparentemente saudáveis, seu tio paterno tivera morte súbita aos trinta e três anos de idade. No exame físico, apresentou-se com extremidades quentes, normocorado, com frequência cardíaca de 78 bpm e pressão arterial de 122 mmHg × 76 mmHg. O ritmo cardíaco era regular em três tempos (presença de quarta bulha) e com sopro sistólico ejetivo de 3+/6 na borda esternal esquerda, com irradiação para segundo espaço intercostal direito e ápice, além de sopro sistólico suave de 2+/6 no quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular. Os demais dados do exame físico não mostraram anormalidades significativas. O eletrocardiograma revelou ritmo sinusal e sobrecarga ventricular esquerda. O ecocardiograma revelou alteração do relaxamento ventricular esquerdo, espessura septal de 32 mm, átrio esquerdo de 44 mm e gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo de 66 mmHg, além de insuficiência mitral moderada associada.

A respeito desse caso clínico, julgue os itens subsecutivos.

46 Esse paciente apresenta uma cardiopatia genética autossômica recessiva transmitida com um padrão hereditário por uma mutação pontual na proteína actina – Val122Ile.

47 A alta velocidade do fluxo sistólico, com direção anterior, ao atingir a via de saída do ventrículo esquerdo dá origem a vetores de fluxo que deslocam o folheto anterior mitral contra o septo, de modo que esse contato da válvula mitral com o septo marca o início da geração do gradiente sistólico subaórtico, o que resulta no gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo do referido paciente.

48 Esse paciente apresenta alto risco para morte súbita.

49 Recomenda-se a solicitação de ressonância magnética com gadolínio para avaliação morfofuncional e pesquisa de realce tardio.

50 Se o irmão do referido paciente for submetido a ecocardiograma e o resultado for normal, isto implicaria estado de não afetação genética no irmão do paciente.

Com relação à etiologia, ao tratamento e à prevenção das doenças associadas ao tabagismo, um grave problema de saúde pública e fator causal de doenças incapacitantes e fatais, julgue os itens a seguir.

51 O tabagismo está associado ao desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que se caracteriza por uma progressiva gravidade da obstrução ao fluxo aéreo, determinada na espirometria pela medida do volume expiratório final forçado no primeiro segundo pós-broncodilatador (VEF_1%-Pós-BD).

52 O tabagismo é o principal fator associado ao surgimento do câncer superficial de bexiga, devendo o quadro clínico de hematúria em paciente tabagista ser avaliado com exames de urina e ultrassonografia de rins e bexiga; em caso de suspeita de lesão intravesical, a investigação deve ser complementada com cistoscopia com biópsia.

53 O tabagismo aumenta o risco de ocorrência de hipertensão arterial e de hipercolesterolemia, causando efeitos deletérios sobre o sistema cardiocirculatório e aumentando o risco de acidente vascular cerebral (AVC), mas não está associado ao mecanismo de ativação da agregação plaquetária no AVC.

54 A implementação de medidas de prevenção secundária, incluindo-se a cessação do tabagismo, após a síndrome coronariana aguda, reduz a ocorrência de eventos cardiovasculares e aumenta a sobrevida dos pacientes.

55 O **Consenso sobre Abordagem e Tratamento do Fumante** do Instituto Nacional do Câncer (INCA) prevê a indicação de bupropiona associada à terapia farmacológica para a cessação do tabagismo, exceto nos casos de pacientes com risco aumentado de convulsão, utilização de inibidores da monoamina oxidase (IMAO) nos últimos quatorze dias, história pregressa de traumatismo cranioencefálico e acidente vascular cerebral.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentado um caso clínico, seguido de uma assertiva a ser julgada, considerando-se aspectos diversos da clínica médica.

56 Paciente do sexo feminino, cinquenta anos de idade, branca, tabagista, procurou atendimento no pronto-socorro com quadro de dor, aumento do volume abdominal e dispneia de repouso havia três meses. Após avaliação laboratorial e de imagem, foram confirmadas as hipóteses de DPOC e de cirrose hepática Child-Pugh C e a ausência de células neoplásicas e peritonite na citologia do líquido ascítico. As sorologias (anti-HCV, HbsAg, anti-Hbc, anti-Hbc IgG e anti-HIV) foram negativas, os marcadores CEA e α-fetoproteína, anti-LKM1, antimitocôndria, antimúsculo liso e fator antinuclear estavam normais. Foram descartadas todas as patologias de depósito. Nesse caso clínico, para complementar a investigação etiológica, é necessária a avalição do nível plasmático de α1-anti-tripsina para descartar uma possível deficiência dessa enzima, geralmente causada por mutações genéticas.

57 Paciente do sexo masculino, vinte e cinco anos de idade, branco, compareceu ao pronto-socorro com quadro clínico de febre alta, astenia intensa, odinofagia, adenomegalia cervical, dores musculares e petéquias nos membros inferiores havia seis dias. O resultado do hemograma evidenciou anemia (hemoglobina 10 g/dl), leucocitose (20.000 leucócitos/mm^3), plaquetopenia (50.000 plaquetas/mm^3), com presença de leucócitos atípicos e linfoblastos. Nesse caso clínico, devido à presença de blastos no sangue periférico, o diagnóstico de certeza é de leucemia linfoide aguda, não sendo necessário realizar diagnóstico diferencial para confirmar doenças infecciosas.

58 Uma mulher de trinta e dois anos de idade, branca, foi atendida no hospital com quadro de palidez, seguida por cianose e hiperemia de mãos, pés e nariz, após exposição ao frio. A paciente recebeu o diagnóstico de fenômeno de Raynaud e, na investigação, foram afastadas as doenças reumáticas autoimunes. Nesse caso clínico, dado o diagnóstico de fenômeno de Raynaud primário, prescinde-se de exames de seguimento, e a paciente deve ser tratada com betabloqueadores.

59 Um homem com cinquenta e oito anos de idade, pardo, foi atendido no pronto-socorro com queimaduras de segundo grau por escaldamento nos dois membros inferiores. Nesse caso clínico, dado o fato de o paciente ser considerado um grande queimado devido à extensão e à profundidade da queimadura, a primeira conduta no atendimento deve ser providenciar o acesso venoso e iniciar a hidratação venosa de acordo com a fórmula de Parkland, com a infusão de 50% do volume nas primeiras 8 h a partir da hora em que a queimadura tiver ocorrido.

60 Paciente do sexo masculino, trinta e cinco anos de idade, pardo, em situação de rua, foi atendido com quadro clínico de tosse, febre persistente, suor noturno e emagrecimento. Nesse caso clínico, deve-se considerar a suspeita de tuberculose na investigação clínica, devendo-se, por isso, pesquisar se o paciente apresenta coinfecção com o vírus HIV, o que é comum em populações de maior vulnerabilidade social.

61 Uma paciente de trinta e cinco anos de idade, negra, foi encaminhada ao cardiologista com diagnóstico de hipertensão arterial de difícil controle. Ela estava em uso de dois hipotensores de classes distintas em dose plena, sem utilizar diuréticos, e com níveis de pressão arterial acima de 140 mmHg × 90 mmHg. Nesse caso clínico, deve-se indicar à paciente vasodilatadores potentes como hidralazina e minoxidil.

Paciente de trinta anos de idade, do sexo feminino, compareceu ao atendimento médico com quadro de cefaleia e perda visual súbita do olho direito. Ela tinha história pregressa de enxaqueca com aura. O exame oftalmológico evidenciou edema de papila e perda do campo visual periférico, sem sinais de papilite. Os resultados da tomografia computadorizada e da ressonância magnética de crânio foram normais.

A partir desse caso clínico, julgue os itens seguintes.

62 A hipótese de acidente vascular cerebral recente não pode ser descartada, mesmo que os exames de imagem não tenham revelado áreas que indicam infarto ou hemorragia.

63 A hipertensão intracraniana idiopática pode ser considerada após a exclusão de causas secundárias de papiledema.

64 O quadro de edema de papila, sem papilite e neurite retrobular, é a manifestação oftalmológica mais comum da esclerose múltipla.

65 A ausência de vertigem e ataxia são características da enxaqueca da artéria basilar.

No que se refere à síndrome nefrótica e à glomerulopatia membranosa, julgue os itens subsequentes.

66 A maioria dos casos de glomerulopatia membranosa é primária.

67 A glomerulopatia membranosa pode ocorrer em pacientes com infecção pelo vírus HIV.

68 O lúpus eritematoso sistêmico é uma das causas secundárias de nefropatia com quadro histopatológico de glomerulopatia membranosa.

69 A deposição amiloidótica parenquimatosa não é característica da síndrome nefrótica do mieloma múltiplo.

70 A amiloidose é um diagnóstico diferencial e caracteriza-se pela glomerulopatia membranosa.

71 O diabetes melito é uma das causas de síndrome nefrótica e induz a glomerulopatia membranosa.

Paciente do sexo feminino, setenta e seis anos de idade, parda, com história de osteoporose, em uso de bifosfonato oral, havia caído e tinha fraturado o colo de fêmur havia três meses, razão por que fora submetida à cirurgia ortopédica e estava restrita ao leito e necessitava da ajuda de cuidadores para executar as tarefas da vida diária. Ela era hipertensa e estava em uso de medicamentos associados: losartana e hidroclorotiazida e antiagregante plaquetário. Não foram constatadas outras comorbidades e a paciente encontrava-se lúcida e orientada. Sete dias após a cirurgia a paciente passou a apresentar um quadro progressivo de confusão mental e agitação psicomotora.

Com relação ao caso clínico descrito e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os próximos itens.

72 A hipótese de hematoma subdural crônico deve ser considerada em paciente com história de trauma prévio e em uso de antiagregantes plaquetários, sendo a drenagem do hematoma uma opção terapêutica para pacientes sintomáticos e sem contraindicações cirúrgicas.

73 Em pacientes idosos, a confusão mental súbita é critério clínico para o diagnóstico de depressão, e o uso de antidepressivos é indicado para o alívio dos sintomas.

74 A confusão mental é um efeito colateral comum da losartana em idosos, e a suspensão do medicamento é o tratamento de escolha.

75 A desidratação é uma causa comum de confusão mental e agitação psicomotora em idosos, sendo a reposição hidroeletrolítica o tratamento de escolha.

Uma jovem de dezoito anos de idade foi encaminhada por odontologista ao pronto-socorro de clínica médica, em razão de um sangramento sem controle após ela ter passado por uma extração dentária.

A partir desse caso clínico, julgue os itens a seguir.

76 Se os valores de hemoglobina dessa paciente forem de 7,5 g/dL, ela deverá receber transfusão da série vermelha.

77 Se os critérios para o diagnóstico de púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) forem preenchidos, deverá ser indicada transfusão plaquetária.

78 Se a contagem de plaquetas, o tempo de retração do coágulo, o tempo de coagulação e o tempo de protrombina (TAP) estiverem normais, mas o tempo de sangramento e o tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPa) estiverem aumentados, é provável que a paciente tenha doença de von Willebrand, que é a desordem hemorrágica hereditária mais comum.

Com base no que foi estabelecido pelo último **Consenso Brasileiro sobre Infecção por *H. pylori***, julgue os itens seguintes.

79 Para o diagnóstico de infecção por *H. pylori*, deve-se interromper o inibidor da bomba de prótons (IBP) por duas semanas antes da realização da endoscopia digestiva alta, podendo-se substitui-lo por antiácidos, sucralfato e bloqueadores dos receptores H2 da histamina nesse período, o que é muito útil no caso de pacientes sintomáticos.

80 Após o tratamento adequado, resultado negativo no teste rápido da urease confirma a erradicação do *H. pylori*.

81 Um dos tratamentos de primeira linha para erradicação do *H. pylori* consiste no esquema tríplice anti-*H. pylori* convencional: IBP + amoxicilina + claritromicina, de 12 h em 12 h durante sete dias.

Um homem de sessenta e sete anos de idade, portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS), buscou atendimento médico queixando-se de dispneia ao andar até o trabalho (média distância), iniciada no último ano, e fadiga durante o dia. Ele relatou que começou a seguir a prescrição médica de losartana 50 mg/dia somente nos últimos quatro meses, apesar da recomendação ter sido dada havia dois anos. No exame clínico, foram constatados murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventícios, ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas e PA = 130 mmHg × 80 mmHg. Os resultados dos exames laboratoriais não revelaram alterações. No mesmo dia do atendimento médico, o paciente foi submetido a ecocardiograma, cujo resultado mostrou fração de ejeção de 55% (VR > 50%), disfunção diastólica e NT-proBNP de 210 pg/mL (VR < 161 pg/mL).

A respeito desse caso clínico, julgue os próximos itens.

82 O tratamento farmacológico desse paciente deve incluir a furosemida.

83 É adequado prescrever espironolactona para esse paciente, pois ela diminui a probabilidade de internações em casos semelhantes ao relatado.

84 Para o correto acompanhamento desse paciente, deve-se solicitar a ele a realização de novo ecocardiograma após seis meses desde o atendimento referido no caso apresentado.

85 Supondo-se que, na próxima consulta, esse paciente apresente piora clínica, com dispneia a curtas distâncias e até mesmo ao se vestir, e que seus exames laboratoriais indiquem diagnóstico inaugural de diabetes melito, o antidiabético oral de escolha deverá ser a glitazona.

Um homem de cinquenta e quatro anos de idade, etilista e portador de cirrose, compareceu a atendimento médico com quadro de dor intensa nas pernas, oliguria e astenia. Até o momento do atendimento, a única medicação que ele usava era o diclofenaco sódico 50 mg, de 8 h em 8 h. No exame clínico, apresentava estado geral regular, emagrecido, abdome escavado, sinal de piparote negativo, FC = 100 bpm, PA = 110 mmHg × 70 mmHg, creatinina = 2,5 mg/dL, ureia = 60 mg/dL, sódio urinário baixo, osmolaridade urinária alta e densidade urinária alta. Sua avaliação pulmonar não mostrou alterações.

Tendo como referência o caso clínico apresentado, julgue os itens que se seguem.

86 A reposição volêmica será capaz de reverter esse quadro, que é típico da síndrome hepatorrenal.

87 Nesse caso, é correto descartar a hipótese diagnóstica de necrose tubular aguda (NTA) pela ausência de isostenúria.

88 O tratamento desse paciente deve ser direcionado à melhora do fluxo sanguíneo renal, com recomendação médica de hidratação e suspensão do diclofenaco.

89 A concentração urinária do biomarcador NGAL (*neutrophil gelatinase-associated lipocalin*) auxilia no diagnóstico etiológico de lesão renal em pacientes portadores de cirrose.

90 O transplante hepático é o tratamento de eleição para esse paciente.

Uma mulher de sessenta e cinco anos de idade foi atendida no pronto-socorro orientada, consciente, com febre de 38 °C, dispneia e tosse produtiva (secreção amarelada) persistente havia três dias. Ela informou fazer uso de enalapril 20 mg/dia para controle da hipertensão arterial. Disse que nunca ficava doente e que, por essa razão, nunca tinha sido internada. No exame clínico, apresentava temperatura axilar = 38,2 °C, saturação de O_2 = 93%, frequência respiratória = 35 irpm, creptos basais, bilaterais, e pressão arterial = 90 mmHg × 50 mmHg. Sua radiografia de tórax confirmou consolidação basal nos lobos inferiores direito e esquerdo. Sua gasometria estava dentro da normalidade. Demais exames mostraram glicemia = 96 mg/dL; ureia = 40 mg/dL e creatinina = 1,2 mg/dL.

Com referência a esse caso clínico, julgue os itens subsequentes.

91 Essa paciente deve ser internada na UTI, por apresentar pneumonia adquirida na comunidade (PAC) grave.

92 Nesse caso, o CURB-65, que é um dos escores de avaliação da gravidade da pneumonia adquirida na comunidade (PAC), pode ser calculado com os dados da história clínica dessa paciente.

93 A amoxicilina associada ao ácido clavulânico em monoterapia consiste em tratamento empírico adequado para essa paciente.

Uma mulher de cinquenta e oito anos de idade, portadora de diabetes melito tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemia, compareceu em consulta médica de rotina apresentando exames com os seguintes resultados: glicemia de jejum = 99 mg/dL; hemoglobina glicada = 7,0%; LDL colesterol = 100; microalbuminúria = 60; e calcificação arterial coronariana (CAC) > 10. Ela não apresentou queixas e informou que faz uso de medicação anti-hipertensiva e antidiabético oral há três anos e que nos últimos seis meses segue rigorosamente plano alimentar saudável e prática de atividade física regular (150 min/semana).

A respeito desse caso clínico, julgue os itens a seguir, segundo a última diretriz conjunta da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Diabetes.

94 Por ser uma paciente considerada de alto risco cardiovascular, recomenda-se a prescrição de terapia antiplaquetária.

95 A pioglitazona e inibidores de DPP4, ou análogos GLP-1, são opções seguras e adequadas para o controle glicêmico dessa paciente.

96 Para essa paciente, é altamente recomendável iniciar a terapia com estatina.

97 Os diuréticos ou bloqueadores dos canais de cálcio (BCC) são indicados como monoterapia inicial para o controle da hipertensão nessa paciente.

Uma jovem de vinte anos de idade, com diagnóstico recente de lúpus eritematoso sistêmico (LES), compareceu à consulta médica apresentando exames que evidenciaram proteinúria ≥ 0,5 g/24 h com hematúria dismórfica glomerular e cilindros celulares.

Com relação a esse caso clínico, julgue os itens subsecutivos.

98 Haja vista o anterior diagnóstico de LES e os resultados dos exames complementares, é correto afirmar que a paciente está com nefrite lúpica.

99 A hidroxicloroquina é recomendada como terapia padrão tanto para portadores de LES quanto para portadores da artrite reumatoide.

100 Os anticorpos anti-Sm são mais específicos para o diagnóstico de LES que a pesquisa de fatores antinucleares (FAN).